

HEMORRAGIES DU POST-PARTUM

Réalisé par :

[Safae hadrachi](#)

[Rim hachami](#)

[Med amine hachem](#)

[Med halout](#)

[Anas hamdaoui](#)



PLAN:

01

INTRODUCTION

02

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

03

DIAGNOSTIC

04

FACTEURS DE RISQUES/ETIOLOGIES

05

COMPLICATIONS

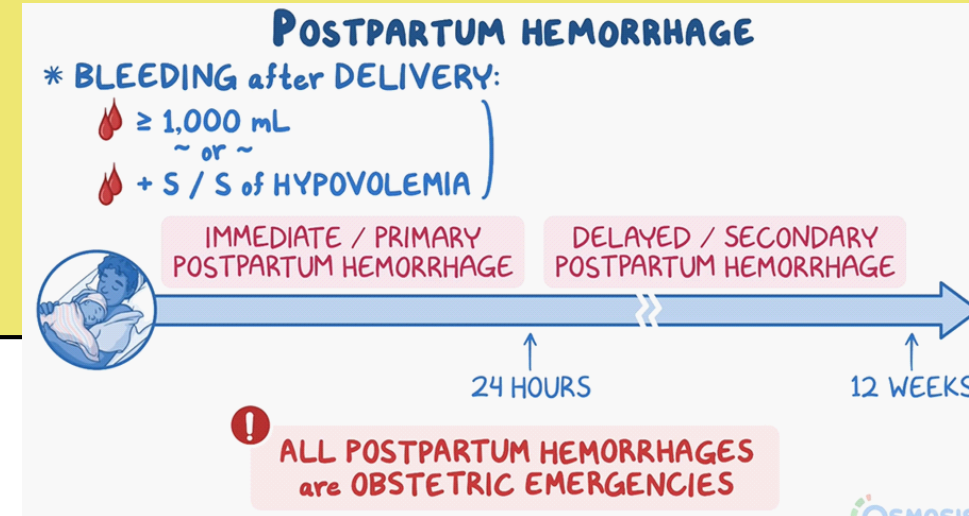
06

PRISE EN CHARGE

07

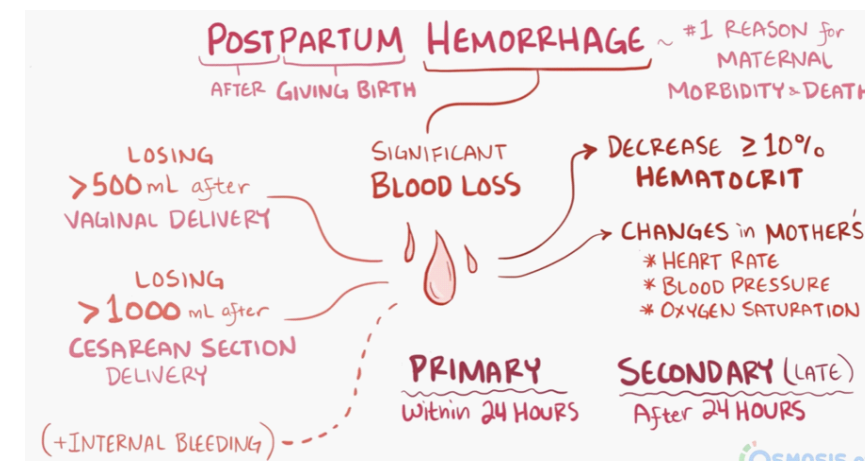
CONCLUSION

INTRODUCTION



Hémorragie d'origine utérine survenant dans les 24 premières heures suivant l'accouchement, et dont les pertes estimées dépassent 500mL.

C'est la première cause de mortalité maternelle **EVITABLE**.



PHYSIOLOGIE DE L'HEMOSTASE LORS DE L'ACCOUCHEMENT

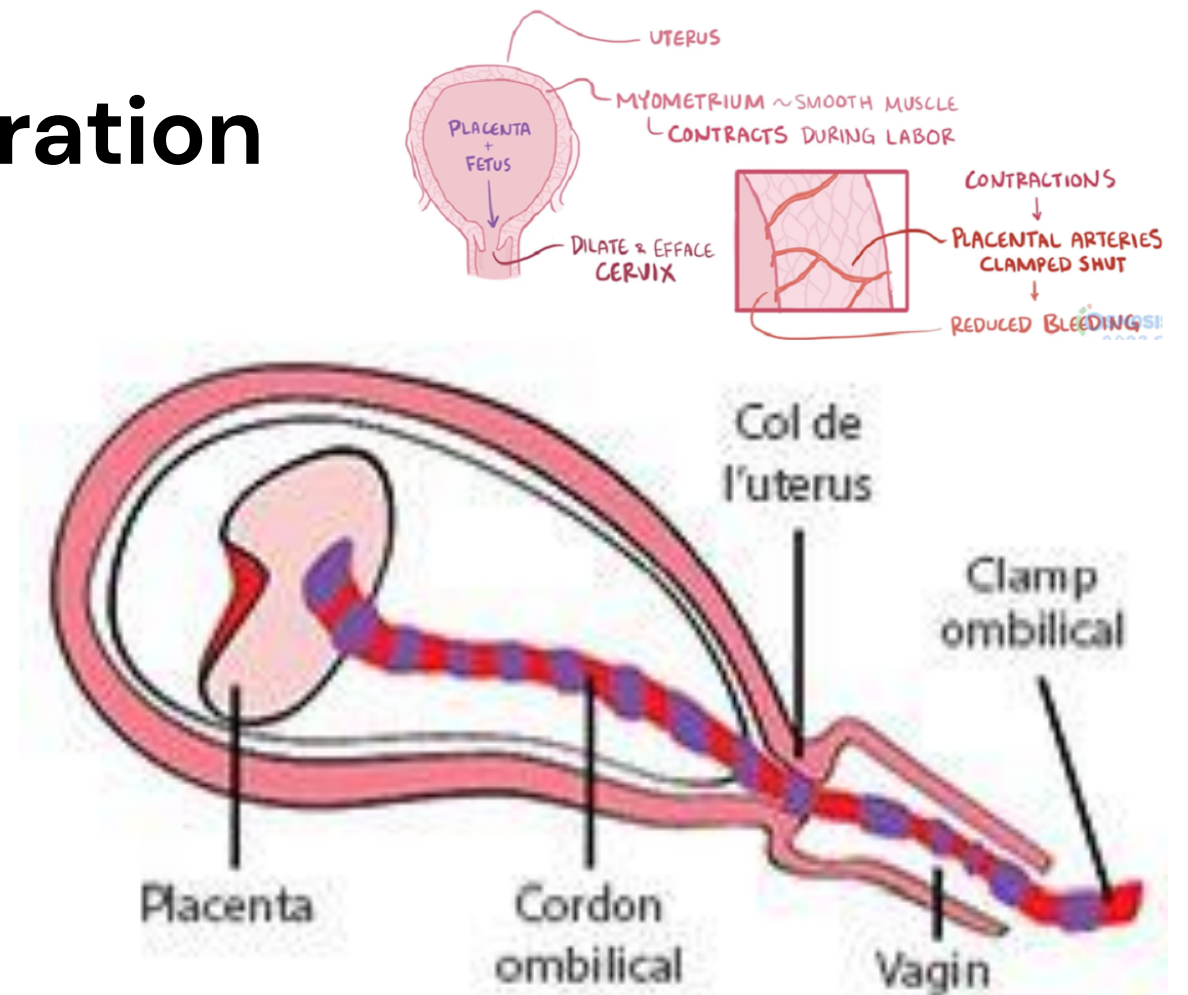
Hémostase temporaire: rétraction utérine → obturation vaisseaux utérins

- compression des artères spiralées:
- compression des sinus Veineux

Rétraction utérine possible si évacuation complète de l'utérus

Hémostase définitive (mécanismes habituels de la coagulation)

- Pré-partum : hyper-coagulabilité
(augmentation: fibrinogène, II, VII, X, VIII Willebrand)
(Placenta: thromboplastines procoagulantes)



PHYSIOLOGIE DE L'HEMOSTASE LORS DE L'ACCOUCHEMENT

La délivrance physiologique doit réunir 4 conditions :

- **Délivrance complète**
- **Vacuité utérine complète**
- **Bonne rétraction utérine**
- **Coagulation sanguine normale**

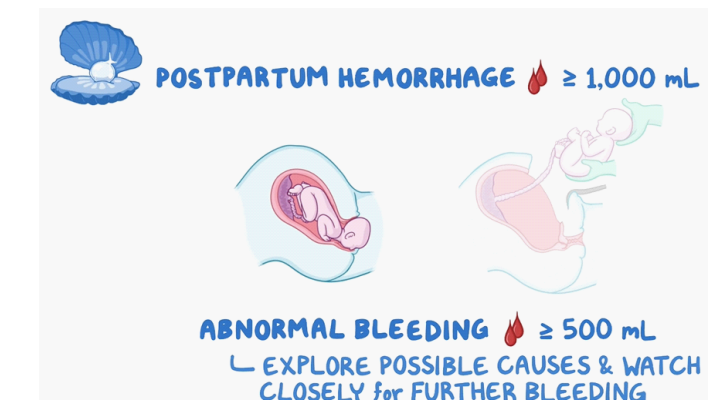
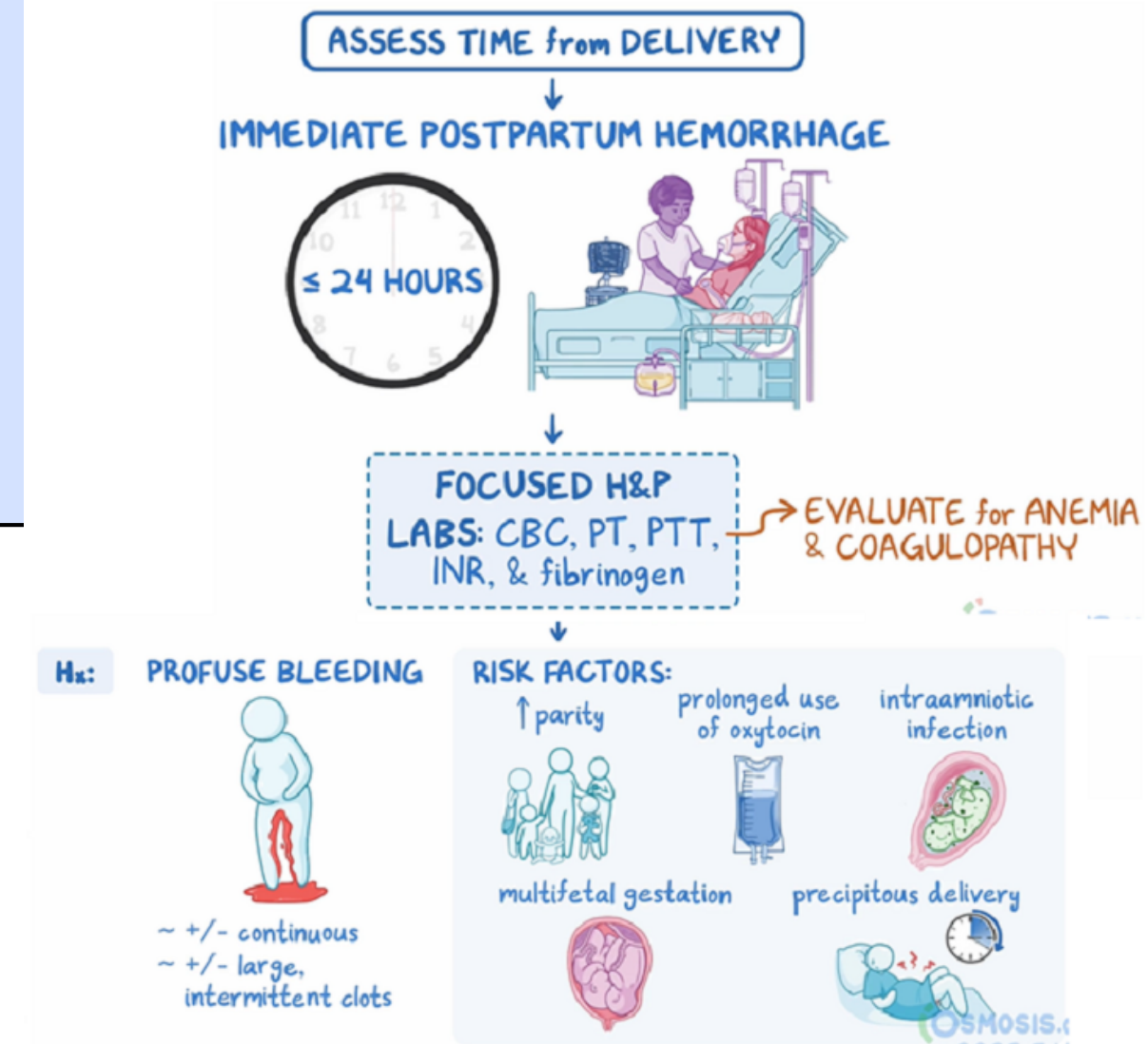
Une anomalie d'une ou de plusieurs de ces conditions risque d'entraîner une hémorragie de la délivrance .



Diagnostic

clinique :

- Des **pertes sanguines** en provenance du tractus génital égales ou supérieures à 500 mL après un accouchement .
- Signes de mal tolérance : hypotension artériel , tachycardie , pâleur cutané.
- Examen sous valves
- Révision utérine



Diagnostic

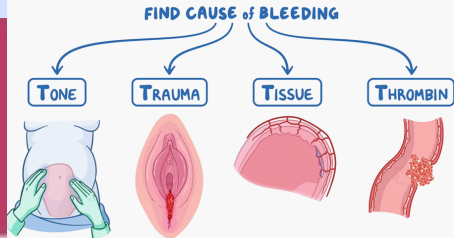
Paraclinique :

- NFS
- Groupage ABO-rhesus .
- TP , TCA, fibrinogène++++
- Fonction rénal .
- Echographie pelvienne .

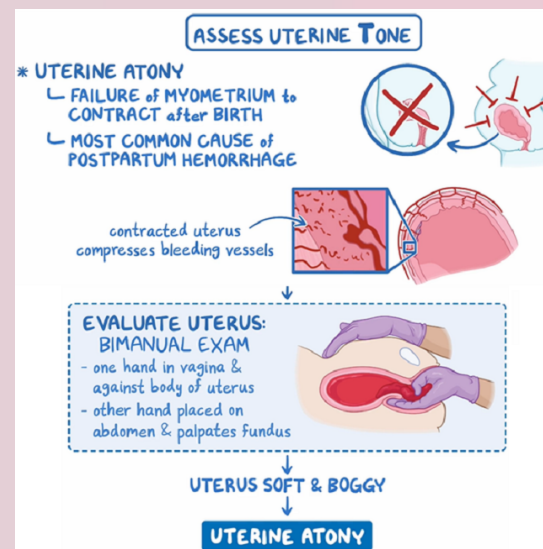
Mais la perturbation du bilan est **trop tardive** par rapports les signes cliniques , ils servent essentiellement à déterminer la cause et **la gravité** de l'hémorragie.



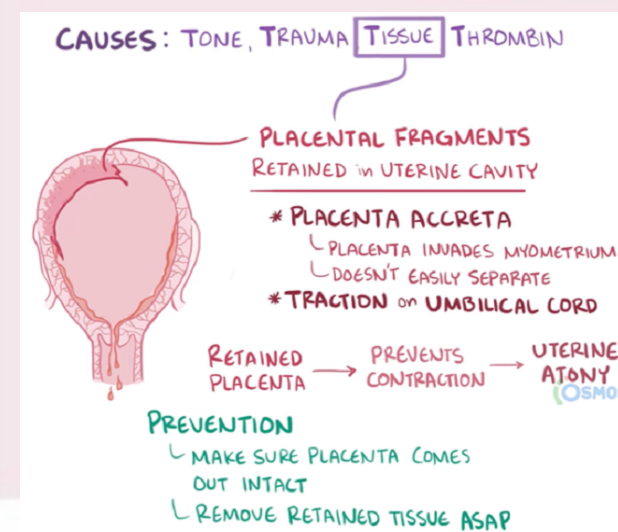
FDRS ET Etiologies



Anomalies des contractions utérines (Tonus)



Rétention de produits de la conception (Tissu)



Processus étiologique

Surdistension utérine

Épuisement musculaire utérin

Infection intra-amniotique

Distorsion fonctionnelle ou anatomique de l'utérus

Produits non éliminés
Placenta de cotylédon
Placenta incomplet

Caillots de sang non éliminés

Facteurs de risque cliniques

Polyhydramnios
Grossesse multiple
macrosomie

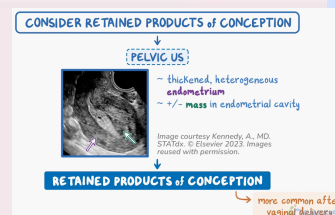
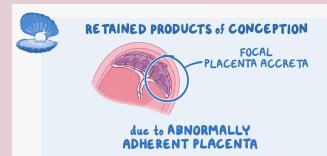
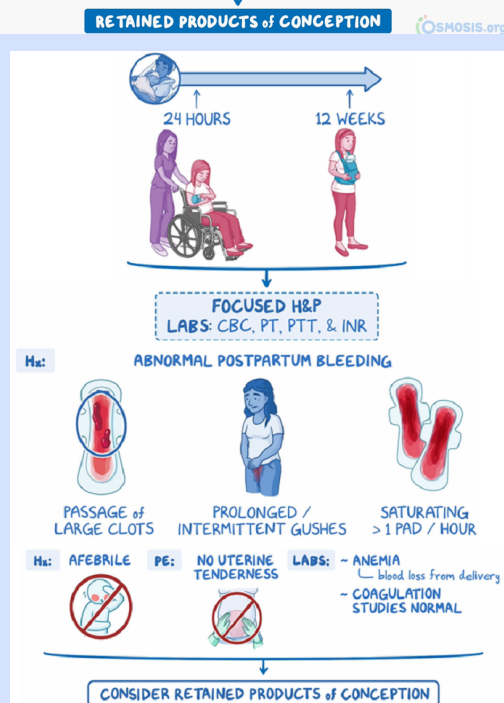
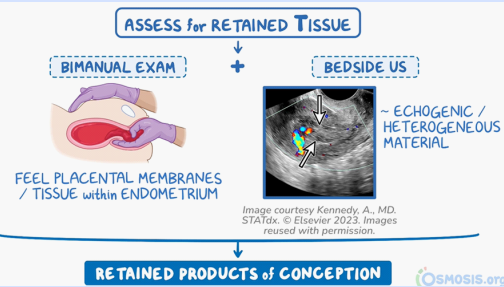
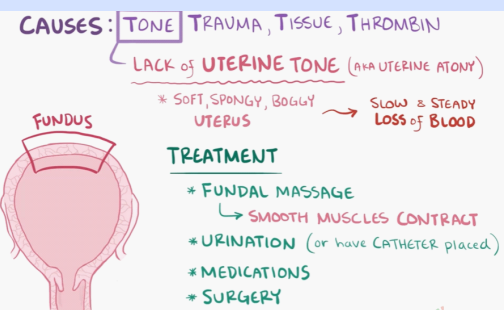
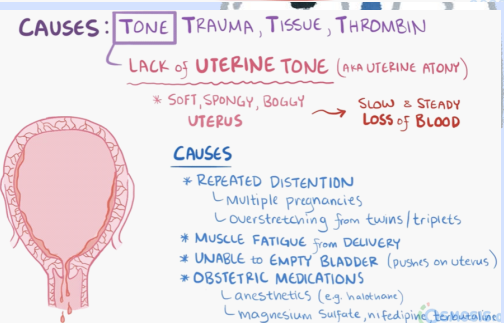
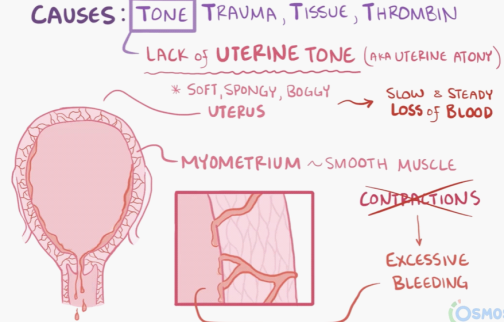
Travail rapide
Travail prolongé
Grande multiparité

Fièvre
Rupture de membranes prolongée

Utérus fibreux
Placenta prævia
Anomalies utérines

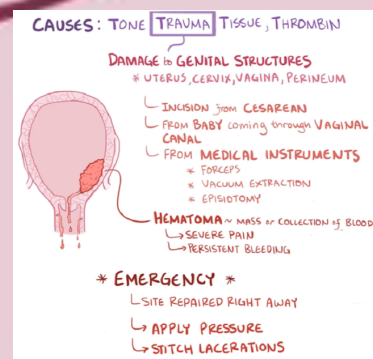
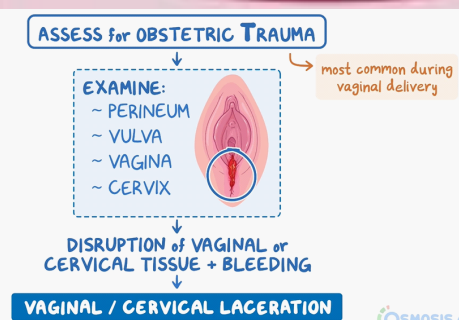
Chirurgie utérine antérieure
Grande multiparité
Placenta anormale à l'ultrason

Inertie utérine

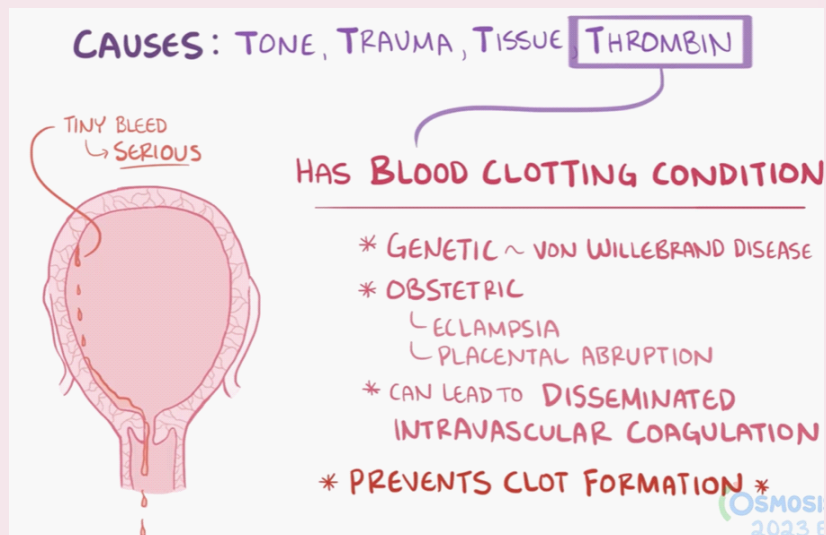
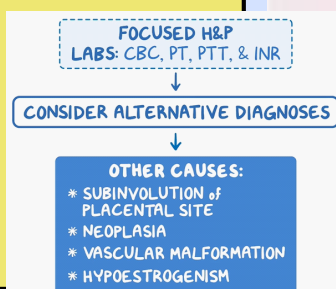


FDRS ET Etiologies

Traumatisme du tractus génital (Traumatisme)



Anomalies de la coagulation (thrombine)



Processus étiologique

Lacération du col, du vagin ou du périnée

Extension ou lacération de la césarienne

Rupture utérine

Inversion utérine

Conditions préexistantes
Hémophilie A
Maladie de Von Willebrand

- Acquisées durant la grossesse
- PTI
- Thrombopénie avec pré-éclampsie
- CVID

Pré-éclampsie
MFIU
Infection grave
Détachement placentaire
Embolie du liquide amniotique
Anti-coagulation thérapeutique

Facteurs de risque cliniques

Délivrance abrupte
Délivrance chirurgicale

Déviations utérines
Engagement profond

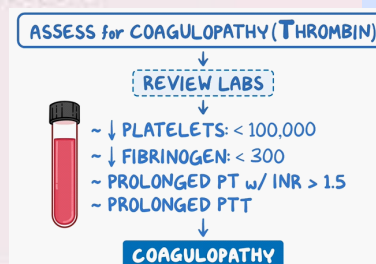
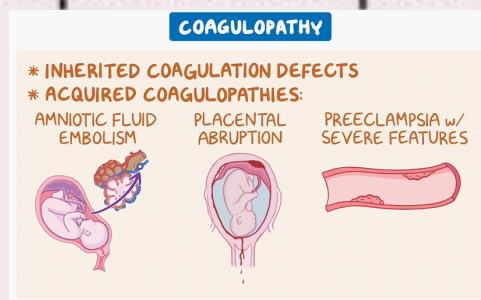
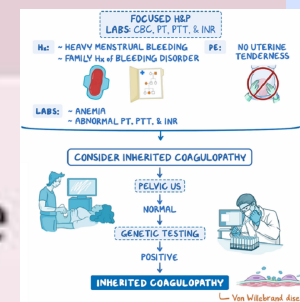
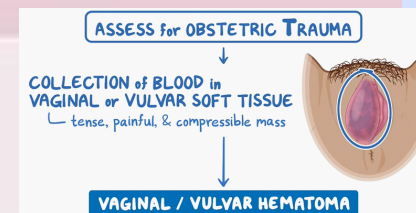
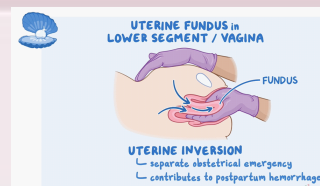
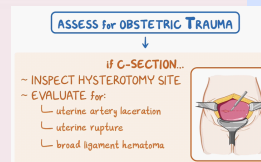
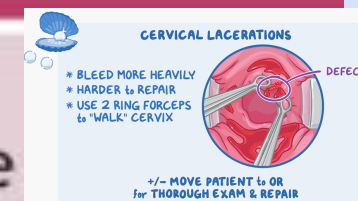
Chirurgie utérine antérieure

Grande multiparité
Placenta fundique

Coagulations héréditaires
Antécédents
De maladie du foie

Ecchymose
Tension artérielle élevée
Mort du fœtus
Fièvre, Nb de globules blancs
Hémorragies antépartum
Collapsus soudain

Antécédent de caillots de sang



COMPLICATIONS



- **Choc hémorragique** (retard des signes cliniques chez jeune parturiente) 
- **Syndrome de défibrination** (CIVD suite au perte des facteurs de coagulation principalement le fibrinogène) 
- **Atteinte rénale** (d'abord fonctionnelle puis organique) 



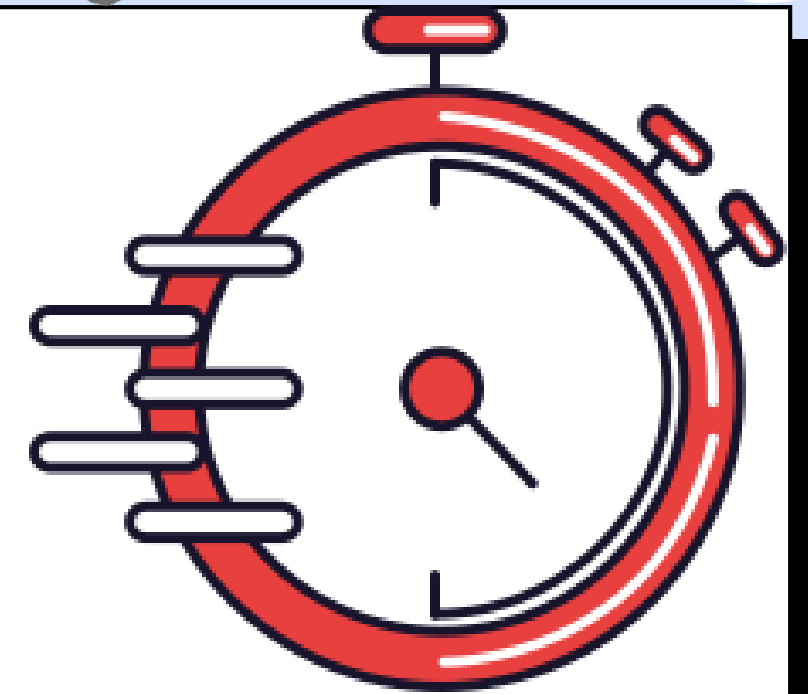
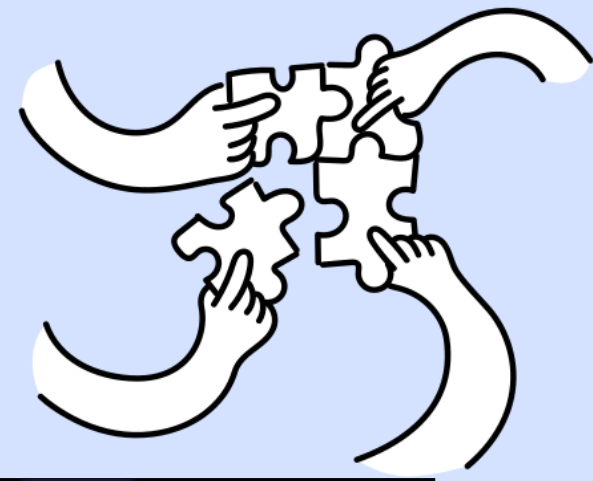
POSTPARTUM HEMORRHAGE

- * **HYPOVOLEMIC SHOCK**
 - ↳ HYPOTENSION, TACHYCARDIA, or SYNCOPÉ
- * **SHEEHAN SYNDROME**
 - ↳ AGALACTORRHEA

**NO FETAL
COMPLICATIONS**

PRISE EN CHARGE

La prise en charge optimale des HPP est multidisciplinaire, réalisée de manière conjointe et simultanée par l'équipe obstétricale et celle d'anesthésie-réanimation, dont chaque intervenant doit être appelé en urgence
(Pronostic vital maternel MEJ)



POSTPARTUM HEMORRHAGE
S

OBSTETRIC EMERGENCY

* MAINTAIN ADEQUATE
CIRCULATING VOLUME
L INTRAVENOUS FLUIDS
L BLOOD PRODUCTS

Mesures de Réanimation



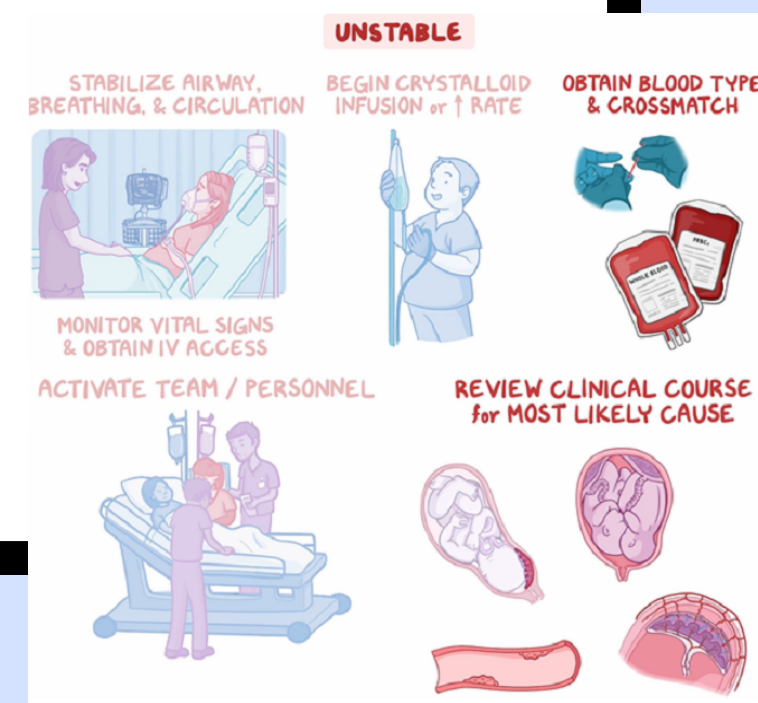
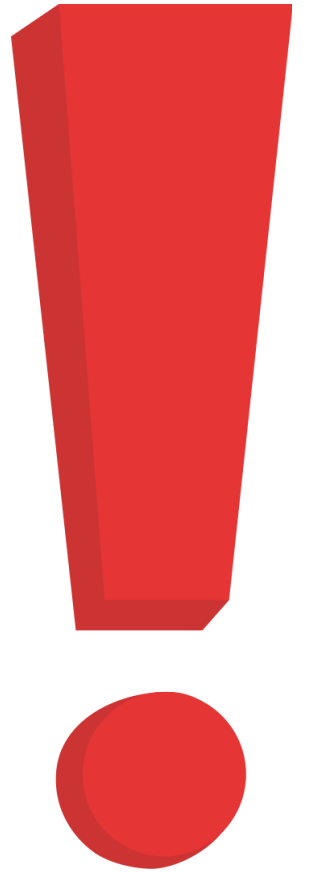
**Traitement étiologique
de l'hémorragie**

MESURES DE REANIMATION

MEC : 2 VVP de bon calibre (VVC si choc persistant) + O2 + SU + Monitoring

Mesures de réanimation :

- **Rétablir la volémie : remplissage +/- drogues vasoactives si pertes importantes**
- **Transfusion (CG – PFC – CP)**
- **Prévenir & TT une CIVD**



PEC OBSTETRICALE



- Révision utérine en urgence**, si le placenta n'est pas expulsé, une délivrance artificielle doit être réalisée en urgence.
- Examen sous valves du col et du vagin**: suture d'une éventuelle épisiotomie ou déchirure périnéale

PEC OBSTETRICALE

- Assurer la contraction utérine:**
perfusion d'ocytociques (dose maximale de 40UI
de syntocinon en IV)
- Massage utérin**

**FAITE EN MÊME TEMPS QUE LES MESURES
DE REANIMATION QUI SONT MIS EN COURS**

PEC OBSTETRICALE



Surveillance rapprochée (globe utérin, arrêt des saignements, TA, FC, diurese...) avec quantification des pertes sanguines (dispositif de recueil).

PEC OBSTETRICALE

On doit considérer que le traitement de première intention est un échec si l'hémorragie persiste 15 à 30 minutes après celui-ci.

Mais une hémorragie très abondante d'emblée ou une mauvaise tolérance hémodynamique maternelle doivent faire réduire ce délai.

PEC OBSTETRICALE

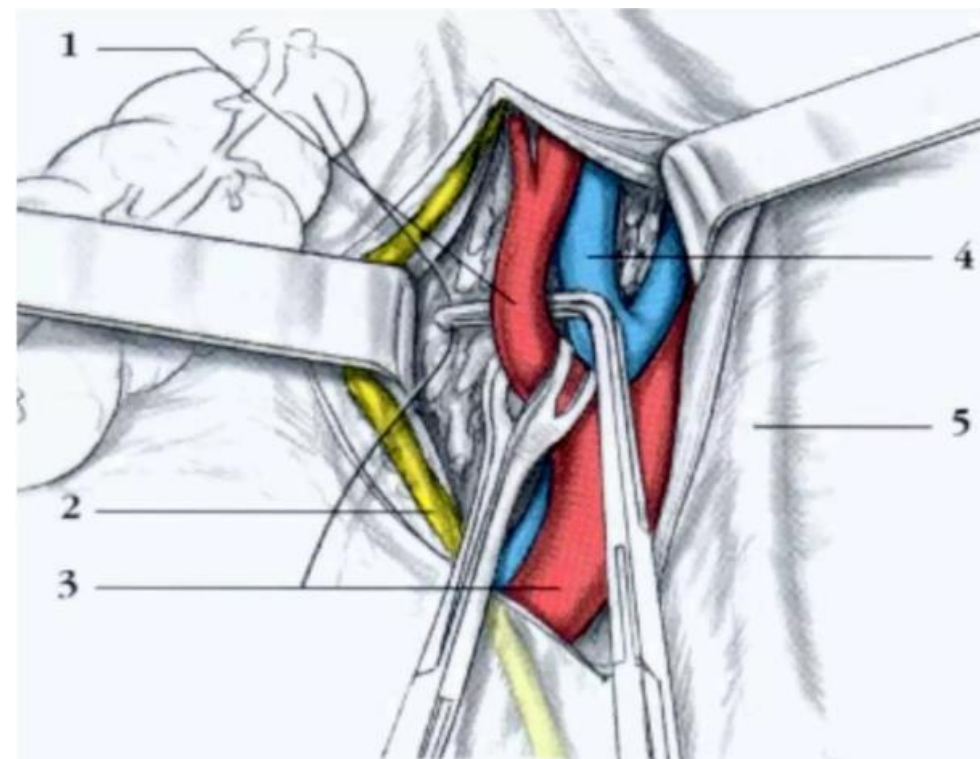
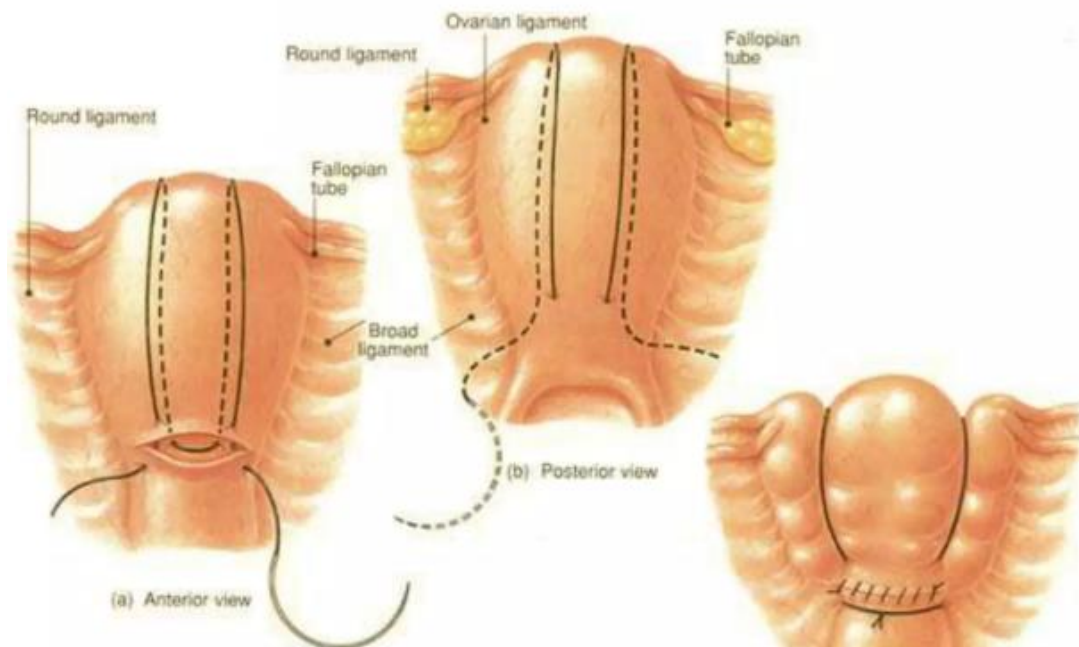
EN CAS D'ECHEC:

- Perfusion IV de prostaglandine (SULPROSTONE 500ug dans 50cc de SS)
- Acide tranexamique 1g
- Poursuivre la réanimation médicale et surveillance

PEC OBSTETRICALE

En cas d'hémorragie **réfractaire** :

- Embolisation artérielle sélective des artères utérines (si stable)
- Ligature chirurgicale des artères hypogastriques, plicature utérine (B-Lynch)

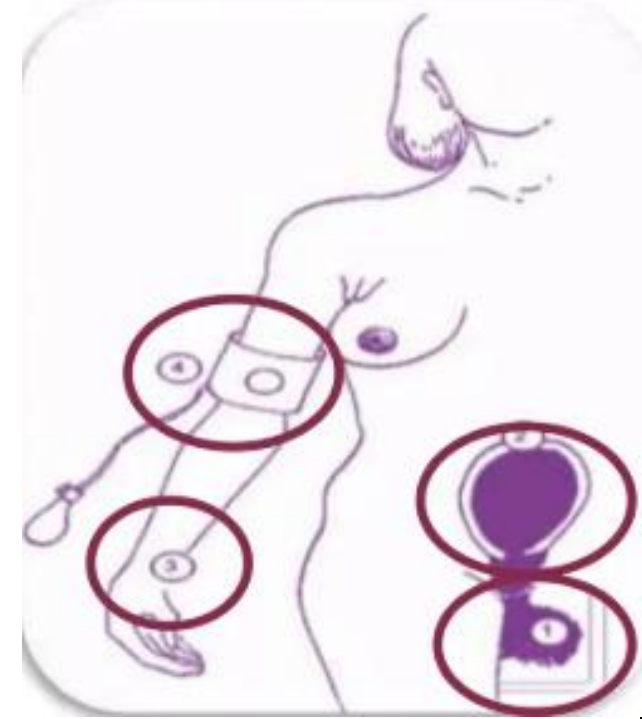


- Hystérectomie d'hémostase en dernier recours.

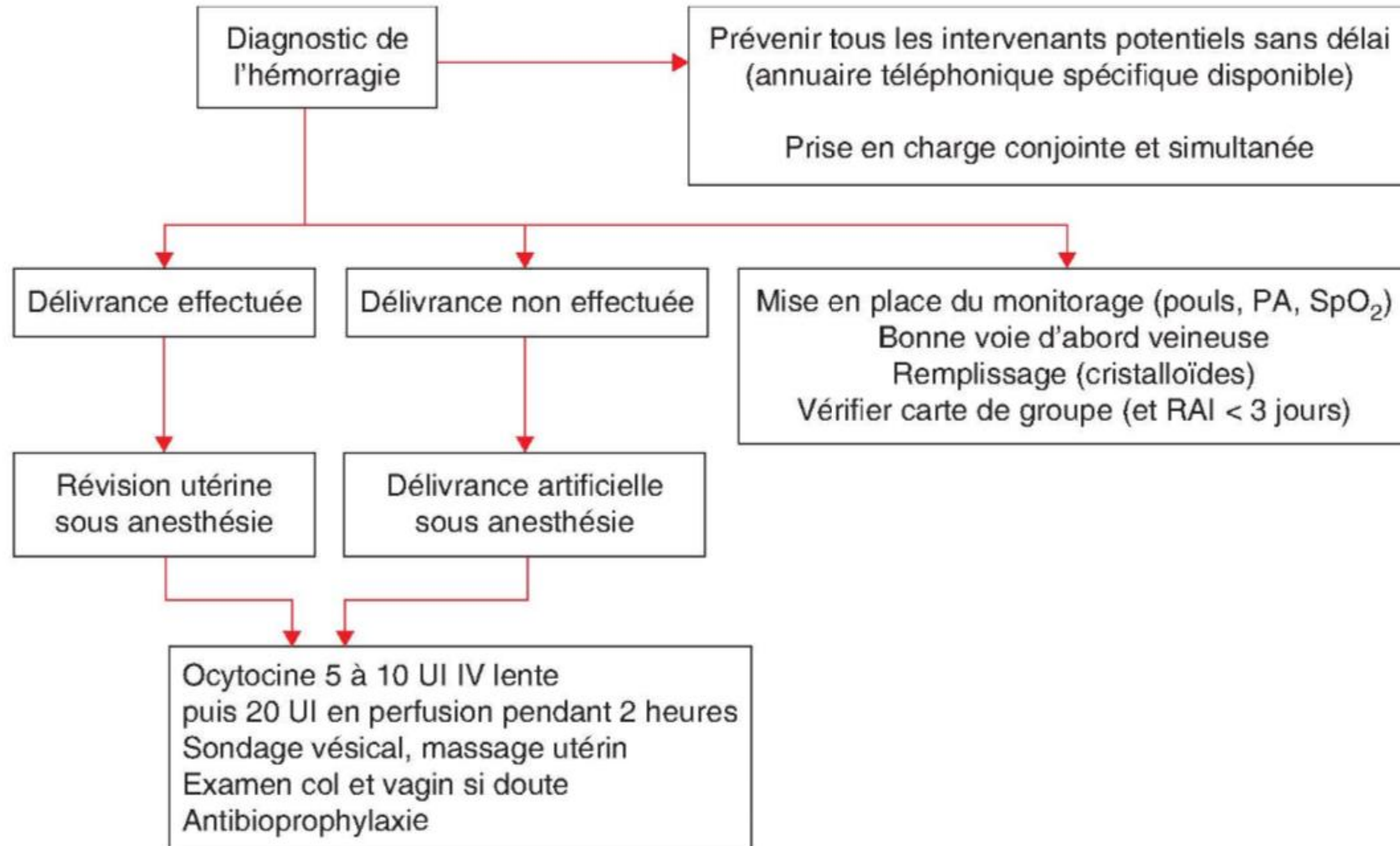
PREVENTION

Principes :

- Vider la vessie.
- surveillance rapprochée (/15min) pendant 2h post partum (pouls+++++++)
- Ne jamais tirer sur le cordon ou le placenta.
- Masser le fond utérin.
- Délivrance dirigée : systématique dès l'expulsion de l'épaule par (Syntocinon®) oxytocine 5-10UI .



CAT



Si l'hémorragie persiste plus de 15 à 30 minutes malgré cette prise en charge initiale, se reporter à la figure 24.2

CAT

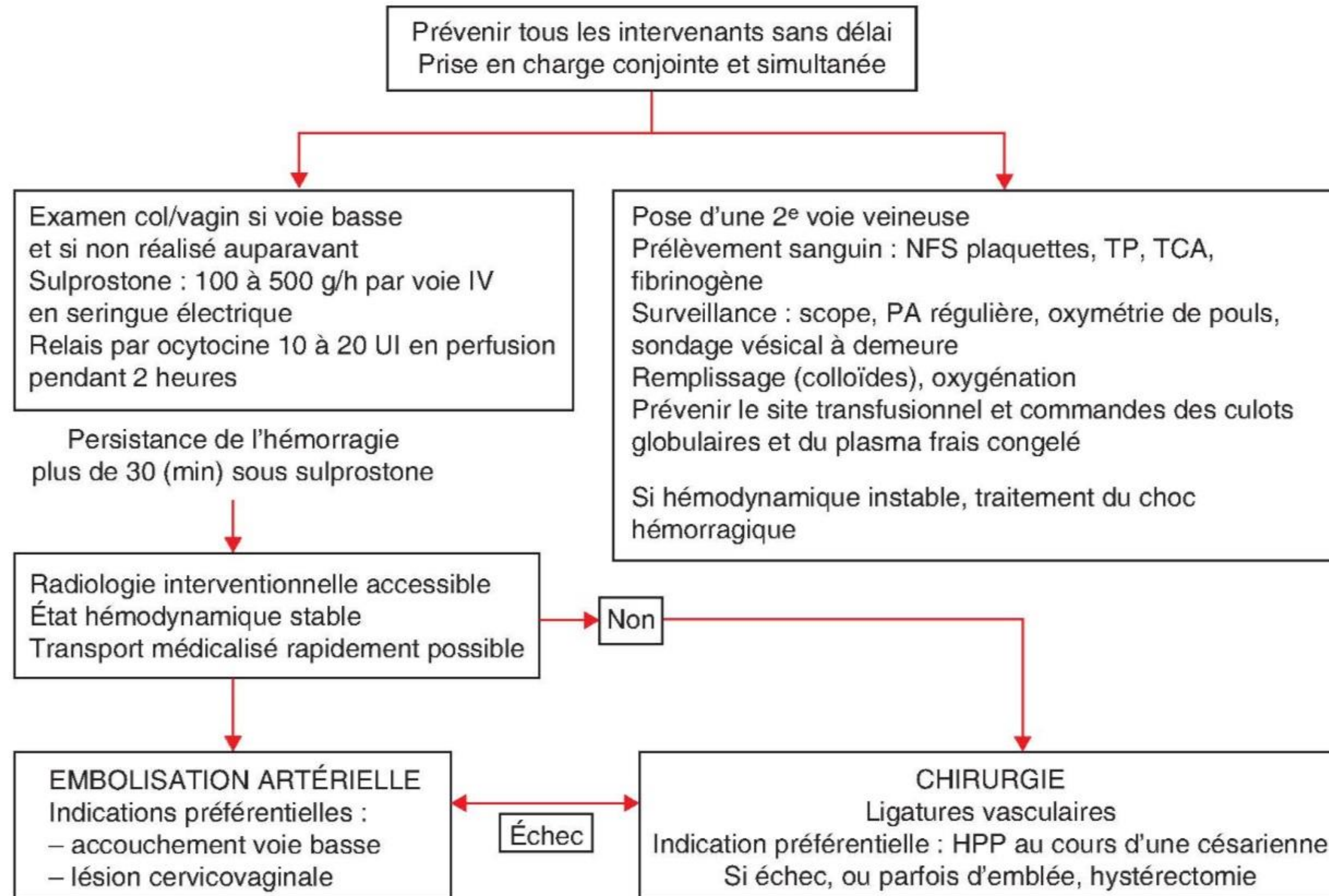
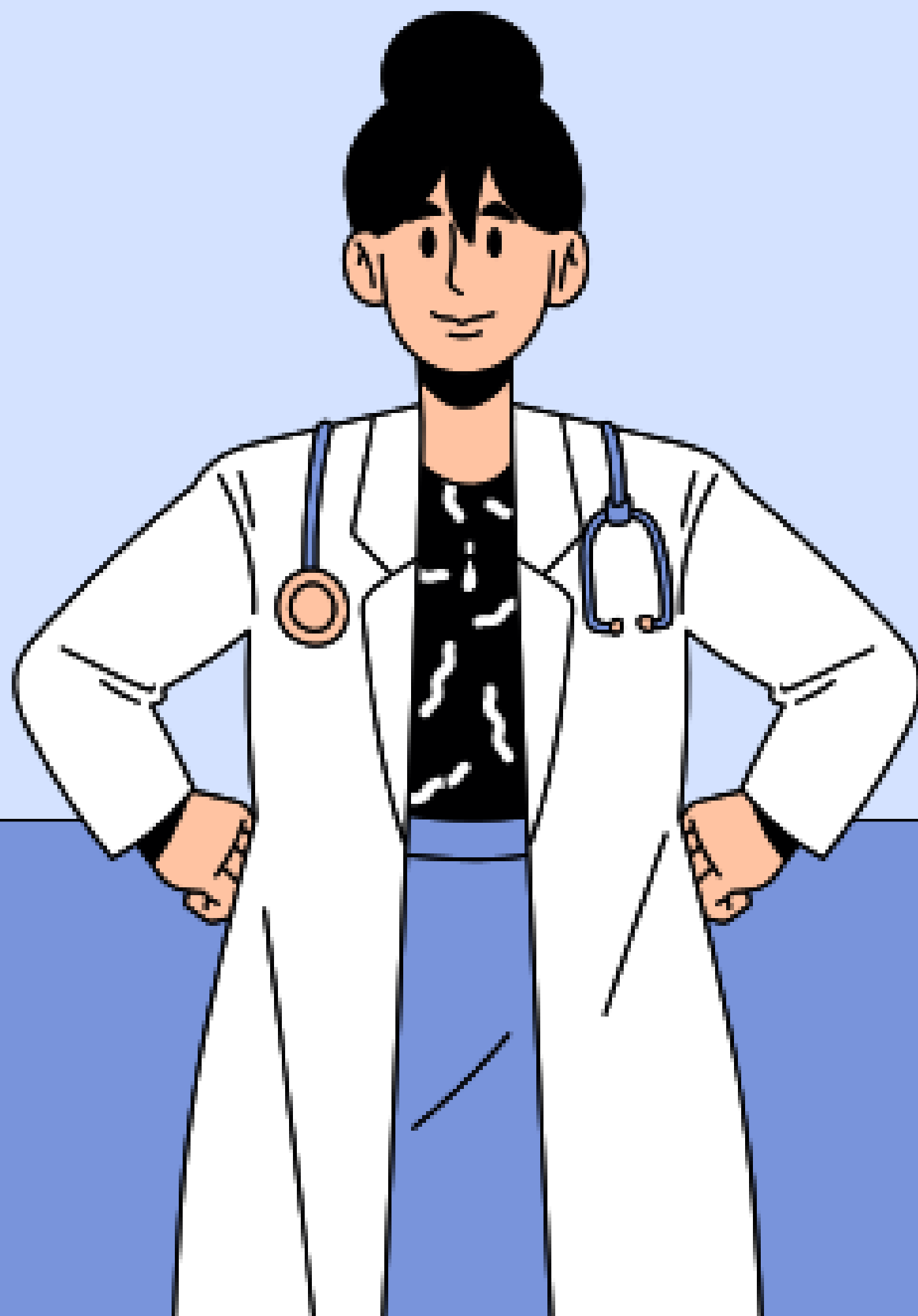
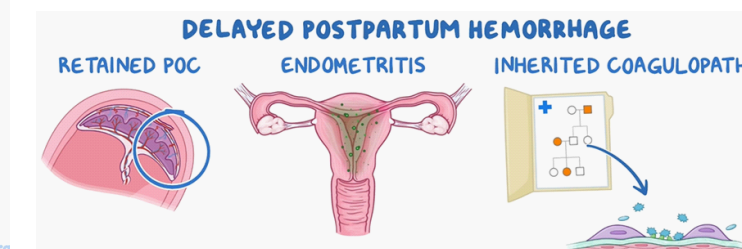
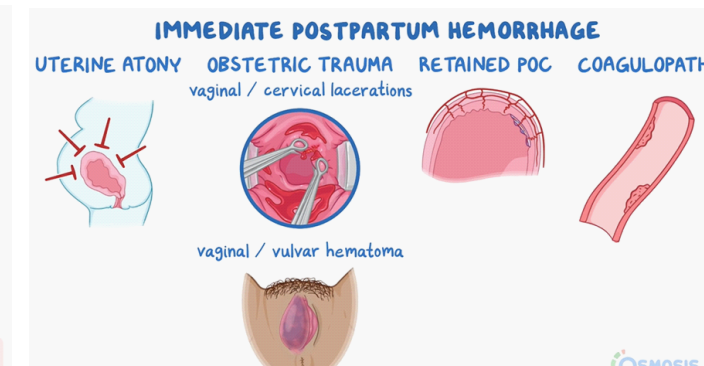
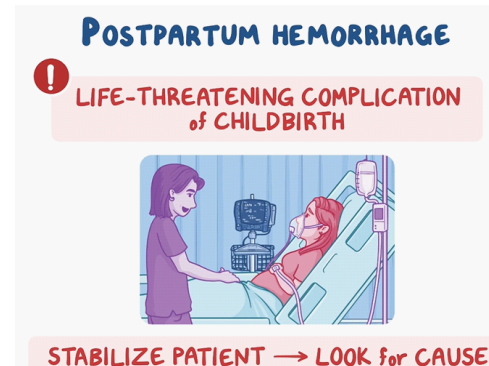


Fig. 22.2. B Prise en charge d'une hémorragie du post-partum immédiat qui persiste au-delà de 15 à 30 minutes.



CONCLUSION :



- . L'HPP constitue une urgence **vitale** et **EVITABLE**
- . L'atonie utérine 1ere cause d'HPP
- . Le diagnostic doit être précoce
- . La PEC multidisciplinaire et immédiate
- . Le facteur temps est un facteur pronostique majeur .

